

1. Datos del paciente

ID Paciente	P007
NHC	NHC-2018-003145
Nombre completo	Adrián Ferrer Blasco
Sexo	Hombre
Fecha nacimiento	03/11/1992
Edad	33 años
DNI	20.987.453-L
Teléfono	622 789 341
Municipio	Castelló de la Plana
Médico responsable	Dra. Elena Martínez Roca
Especialidad	Psiquiatría

2. Antecedentes personales

- Esquizofrenia paranoide, episodios múltiples, actualmente en remisión parcial (diagnóstico 2016, CIE-10: F20.0)
- Primer episodio psicótico a los 24 años con hospitalización involuntaria (2016)
- Segundo episodio psicótico en 2019 por abandono de medicación
- Tabaquismo activo (15 cigarrillos/día)
- Síndrome metabólico iatrogénico secundario a antipsicóticos
- No alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Padre: esquizofrenia diagnosticada a los 30 años, actualmente institucionalizado. Hermano mayor: trastorno esquizoafectivo. Madre: sin patología psiquiátrica conocida.

3. Historia clínica actual

Paciente de 33 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide desde 2016, actualmente en seguimiento ambulatorio regular. El primer episodio psicótico debutó con ideación delirante de perjuicio (creencia de ser vigilado por servicios secretos), alucinaciones auditivas imperativas y conducta desorganizada, requiriendo ingreso hospitalario durante 28 días. Tras el alta se inició tratamiento con risperidona con buena respuesta inicial. En 2019, tras abandono de medicación durante 3 meses, presentó segundo episodio con temática delirante similar y heteroagresividad verbal hacia familiares, precisando nuevo ingreso de 21 días. Se rotó a paliperidona mensual inyectable para mejorar adherencia. Desde entonces estable, sin reingresos. Actualmente presenta síntomas negativos residuales: aplanamiento afectivo, alogia leve, apatía con dificultad para mantener actividades estructuradas y aislamiento social progresivo. Vive con su madre que ejerce de cuidadora principal. Acude a centro de rehabilitación psicosocial 3 días por semana. No consume tóxicos salvo tabaco. Niega ideación autolítica. Funcionamiento global moderadamente deteriorado (EEAG: 55).

4. Exploración

Aspecto general	Consciente, orientado en las tres esferas. Vestimenta adecuada aunque descuidada en higiene personal
Psicomotricidad	Sin agitación ni inhibición. Leve rigidez facial compatible con efectos extrapiramidales leves
Estado de ánimo	Eutímico. Afecto aplanado con escasa modulación emocional

Pensamiento	Curso ligeramente empobrecido. Contenido sin ideación delirante activa. Sin fenómenos de inserción, robo o difusión del pensamiento
Sensopercepción	Niega alucinaciones auditivas o visuales actuales. Refiere haber escuchado 'murmillos' hace 2 semanas, aislados, sin repercusión conductual
Cognición	Atención sostenida ligeramente disminuida. Funciones ejecutivas enlentecidas. Memoria de trabajo deficitaria
Conciencia de enfermedad	Parcial. Acepta diagnóstico y tratamiento pero minimiza gravedad de episodios previos
Peso / Talla / IMC	98 kg · 178 cm · 30,9 kg/m ²
Tensión arterial	138/88 mmHg
Frecuencia cardíaca	76 lpm, rítmica
Perímetro abdominal	108 cm

5. Tratamiento actual

Fármaco	Posología
Paliperidona palmitato 150 mg	Inyección intramuscular mensual (última dosis: 02/04/2026)
Biperideno 2 mg	1 comp. en desayuno y cena (corrector extrapiramidal)
Metformina 850 mg	1 comp. con desayuno y cena (síndrome metabólico)
Atorvastatina 20 mg	1 comp. en cena

6. Resultados de laboratorio

Parámetro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
Glucosa	118 mg/dL	70–110	Alto	112 mg/dL
HbA1c	6,1 %	< 5,7 %	Alto	5,9 %
Colesterol total	242 mg/dL	< 200	Alto	228 mg/dL
Triglicéridos	198 mg/dL	< 150	Alto	185 mg/dL
HDL	38 mg/dL	> 40	Bajo	40 mg/dL
Prolactina	45,2 ng/mL	4,0–15,0	Alto	42,8 ng/mL
Hemograma	Normal	—	Normal	Normal
Perfil hepático	Normal	—	Normal	Normal
CPK	Normal	—	Normal	Normal

7. Plan de actuación

1. Mantener paliperidona palmitato 150 mg/mes. No reducir dosis dada la historia de recaídas
2. Valorar cambio de antipsicótico a aripiprazol depot si la prolactina sigue elevada en próximo control
3. Derivación a Endocrinología para manejo de síndrome metabólico iatrogénico
4. Intensificar programa de rehabilitación psicosocial: añadir taller de habilidades sociales
5. Intervención motivacional para cesación tabáquica
6. Control analítico en 3 meses con glucosa, perfil lipídico, prolactina y HbA1c
7. Revisión psiquiátrica en 6 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.